Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Rinoplasti

Burun estetiği ameliyatı (gerekiyorsa nefes yolu düzeltmesiyle birlikte)

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Planlanan teknik: ☐ Açık teknik ☐ Kapalı teknik ☐ Hekim tarafından ameliyatta belirlenecek

Birlikte yapılacak işlemler: ☐ Septoplasti ☐ Konka küçültme ☐ Yok _____

Kıkırdak grefti kaynağı: ☐ Burun içi (septum) ☐ Kulak ☐ Kaburga ☐ Gerek görülmüyor _____

Hastanın şikâyeti ve beklentisi: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Rinoplasti, burnun dış görünümünü (burun sırtı, kemerli yapı, burun ucu, burun genişliği, burun delikleri, yüzle uyumu) yeniden şekillendirmek için yapılan bir ameliyattır. Burnunuzda nefes almayı zorlaştıran bir eğrilik (septum deviasyonu), burun kanatlarında çökme veya konka büyümesi varsa bunlar da aynı ameliyatta düzeltilebilir.

Burnun şekli doğuştan gelen özellikler, büyüme sırasındaki değişiklikler veya geçirilmiş travmalar (darbe, kırık) nedeniyle oluşur. Bu yapılar kendiliğinden değişmez. Ameliyatın amacı, sizinle birlikte belirlediğimiz **gerçekçi hedeflere** ulaşmak ve **doğal, yüzünüzle uyumlu ve rahat nefes alan** bir burun elde etmektir.

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında yapılır. Ameliyattan önce burnunuz muayene edilir, fotoğraflanır ve sizinle birlikte plan yapılır.

1. **Kesi:** Kapalı teknikte tüm kesiler burnun içindedir ve dışarıdan iz kalmaz. Açık teknikte ek olarak burun delikleri arasındaki ince köprüye (kolumella) yaklaşık 4–5 mm'lik küçük bir kesi yapılır; bu iz zamanla genellikle belirsizleşir.
2. **Burun iskeletinin şekillendirilmesi:** Cilt ve yumuşak dokular nazikçe kaldırılır. Kemer varsa kemik ve kıkırdaktan alınır veya kemer koruyucu tekniklerle düzeltilir. Burun ucu kıkırdakları dikişlerle yeniden şekillendirilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

3. **Kemiklerin daraltılması/düzeltilmesi (osteotomi):** Geniş veya eğri burun kemiklerini daraltmak ve düzeltmek gerekiyorsa kontrollü kemik kesileri yapılır. Bu adım morarma ve şişlik ihtimalini artırabilir.
4. **Destek ve greftler:** Burnun uzun vadede şeklini koruması ve nefes yolunun açık kalması için gerekirse kıkırdak destekleri (greft) kullanılır. Kıkırdak öncelikle burun içinden (septumdan) alınır; yetmezse kulak veya kaburga kıkırdağı kullanılabilir. Bu durum ameliyattan önce sizinle konuşulur.
5. **Fonksiyonel düzeltme:** Gerekliyse burun orta bölmesi (septum) düzeltilir ve konkalar küçültülür.
6. **Kapatma ve atel:** Kesiler ince dikişlerle kapatılır. Burun sırtına koruyucu bir atel (splint) uygulanır; burun içine gerekirse yumuşak silikon atel veya nefes almanıza izin veren tamponlar konur.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi	Yaklaşık 2–4 saat	Genellikle 1 gece hastanede kalış

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Burun şeklinin yüzünüzle daha uyumlu, doğal ve dengeli hâle gelmesi
- Varsa burun tıkanıklığının giderilmesi ve nefes almanın rahatlaması
- Kendinizi daha iyi hissetmenize katkı

Hastaların büyük çoğunluğu sonuçtan memnun kalır. Ancak burun, yüzün ortasında yer alan ve iyileşmesi uzun süren bir organdır; nihai sonuç **12–18 ay** içinde ortaya çıkar. Yayınlarda hastaların yaklaşık **%5–15'inde** küçük ya da büyük bir düzeltme ameliyatına (revizyon) ihtiyaç duyulabildiği bildirilmektedir. Kalın ciltli, daha önce ameliyat olmuş veya ciddi travma geçirmiş burunlarda sonucu öngörmek daha zordur.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Ameliyat olmamak:** Estetik bir işlem olduğu için yaptırmama seçeneğiniz her zaman vardır.
- **Dolgu ile burun şekillendirme ("sıvı rinoplasti"):** Küçük kemer veya çukurlukları geçici olarak kamufle edebilir; burnu küçültmez, nefes almayı düzeltmez ve damar tıkanıklığı gibi kendine özgü riskleri vardır.
- **Yalnızca fonksiyonel cerrahi (septoplasti/konka küçültme):** Tek sorun nefes almaksa burnun dış şekline dokunmadan yapılabilir.
- **İlaç tedavisi:** Alerjiye veya mukoza şişliğine bağlı tıkanıklıkta burun spreyleri fayda sağlayabilir; yapısal eğrilikleri düzeltmez.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa burnunuzun mevcut şekli değişmeden kalır. Nefes alma sorununuz varsa ve nedeni yapısal ise (eğrilik, kanat çökmesi), bu şikâyetler kendiliğinden düzelmez ancak sağlığınız için genellikle acil bir tehlike oluşturmaz.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Son 6–12 ay içinde **izotretinoin** (akne ilacı, ör. Roaccutane) kullandıysanız mutlaka bildiriniz; cilt iyileşmesini etkileyebileceği için ameliyat zamanlaması buna göre planlanabilir.
- Ameliyattan önce kan tahlilleri ve gerekirse diğer tetkikler yapılır; anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Ameliyattan önceki **6–8 saat** boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir (anestezi uzmanının vereceği talimatlara uyunuz).
- Ameliyat günü makyaj, oje, takı ve lens kullanmayınız. Ameliyattan sonraki ilk gün size eşlik edecek bir yakınınızın olması önerilir.
- Yüzde aktif sivilce, cilt enfeksiyonu, grip veya üst solunum yolu enfeksiyonu varsa ameliyat ertelenebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 48 saat	Burunda tıkanıklık, hafif sızıntı, baş ağrısı ve yüzde şişlik olur. Ağrı genellikle hafif–orta düzeydedir ve ağrı kesicilerle kontrol edilir. Başınızı yüksekte tutarak yatmanız ve soğuk uygulama şişliği azaltır. Morarma **olursa** göz çevresinde görülür ve 7–10 günde çekilir.
1. hafta	Burun içi silikon atel/tamponlar varsa genellikle 2–5. günlerde, burun dışındaki atel ve dikişler yaklaşık **7. günde** çıkarılır. Burun içini serum fizyolojik ile temizlemeniz istenir. Çoğu hasta 7–10 gün içinde masa başı işine ve sosyal hayata döner.
2–6. haftalar	Şişliğin büyük kısmı geçer, ancak burun ucu sertliği ve hafif uyuşukluk devam edebilir. Ağır egzersiz, temas sporları ve yüzme yaklaşık **4–6 hafta** ertelenmelidir. Gözlük, burun sırtına baskı yapmayacak şekilde en az **6 hafta** takılmamalı veya bantla askıya alınmalıdır.
3–12. aylar	Kalan şişlik, özellikle burun ucunda, yavaş yavaş azalır. Bu dönemde burnun şekli değişmeye devam eder; erken dönemde görülen küçük düzensizlikler genellikle kaybolur.
12–18. aylar	Nihai sonuç ortaya çıkar. Gerekli görülürse düzeltme (revizyon) işlemi için genellikle en az 12 ay beklenir.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Burun tıkanıklığı, burunda hafif sızıntı ve kanlı akıntı (ilk günler)
- Yüzde ve göz çevresinde şişlik; morarma **olursa** 1–2 hafta içinde geçer
- Burun ucunda ve ön dişlerde geçici uyuşukluk, burun ucunda sertlik
- Koku almada geçici azalma (şişlik geçtikçe düzelir)
- Burnun şeklinin aylar boyunca değişmeye devam etmesi

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Uzun süren şişlik** — Özellikle kalın ciltlerde burun ucundaki şişlik 1 yıl veya daha uzun sürebilir. Gerekirse kortizonlu iğne ile desteklenebilir.
- **Hafif asimetri ve küçük düzensizlikler** — Yüzün kendisi tam simetrik olmadığından burunda hafif farklılıklar kalabilir; elle hissedilen ama genellikle görünmeyen küçük kemik/kıkırdak çıkıntıları olabilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Revizyon (düzeltme) ihtiyacı** — Yaklaşık 100 hastadan **5–15'inde**, küçük bir dokunuştan daha kapsamlı bir ameliyata kadar değişen düzeltme işlemi gerekebilir.
- **Burun içinde kabuklanma ve kuruluk** — İlk haftalarda sıktır; düzenli yıkama ve nemlendirici ile geçer.

Seyrek görülen durumlar

- **Burun kanaması** — Yaklaşık 100 hastadan **1–3'ünde** tamponlama veya müdahale gerektiren kanama olabilir. Çok nadiren ameliyathanede kanamanın durdurulması gerekebilir.
- **Enfeksiyon** — 100 hastada **1'den az–3** oranında görülür. Genellikle antibiyotikle düzelir; nadiren iltihabın boşaltılması veya greftin çıkarılması gerekebilir.
- **Nefes almada beklenen düzelmenin olmaması** — Burun tıkanıklığınız tamamen geçmeyebilir veya nadiren artabilir; ek tedavi veya ameliyat gerekebilir.
- **Septum delinmesi (perforasyon)** — Burun orta bölmesinde delik oluşması yaklaşık 100 hastada **1** civarındadır. Çoğu zaman şikâyet yapmaz; ıslık sesi, kabuklanma veya kanamaya neden olursa tedavi gerekebilir.
- **Septumda kan veya iltihap toplanması (hematom / apse)** — Septum üzerinde işlem yapıldığında 100 hastada **1'den az** görülür. Ameliyattan sonraki günlerde artan tıkanıklık, ağrı ve ateşle belirti verir. Burun kıkırdağına zarar vermemesi için **acilen boşaltılması** gerekir; tedavi edilmezse kıkırdak kaybı ve burun sırtında çökme (semer burun) gelişebilir ve düzeltilmesi için ek ameliyat gerekebilir.
- **Burun içi yapışıklık (sineşi)** — Burun içi dokuların birbirine yapışmasıdır; tıkanıklığa yol açarsa basit bir işlemle ayrılır.
- **Belirgin iz** — Açık teknikte kolumelladaki iz nadiren belirgin kalabilir; kanat daraltma yapılırsa burun kanadı kıvrımında ince iz oluşur.
- **Uzun süren uyuşukluk** — Burun ucunda veya ön dişlerde his azalması birkaç ay sürebilir; nadiren kalıcı olabilir.
- **Greftle ilgili sorunlar** — Kullanılan kıkırdak zamanla yer değiştirebilir, eğrilebilir, erime gösterebilir veya ciltten belli olabilir. Kulak veya kaburgadan kıkırdak alınırsa o bölgede ağrı, iz, kanama ve kaburga için çok nadiren akciğer zarı yaralanması (pnömotoraks) riski vardır.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **Cilt sorunları** — Cilt incelmesi, kızarıklık, küçük kılcal damarlar veya kalın ciltte iz dokusu artışı. Çok nadiren, özellikle sigara içenlerde ve daha önce ameliyat olmuş burunlarda, cilt beslenmesinin bozulmasına bağlı yara ve doku kaybı görülebilir. Bu durumda uzun süreli yara bakımı ve onarıcı ameliyat gerekebilir; kalıcı iz veya şekil bozukluğu kalabilir.
- **Koku almanın kalıcı azalması veya kaybı** — Çok nadirdir.
- **Gözyaşı kanalı sorunları ve göz çevresi kanaması** — Kemik kesilerine bağlı olarak çok nadiren sulanma veya göz çevresinde kanama görülebilir.
- **Beyin-omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı, menenjit, görme kaybı** — Burun ile kafa tabanı ve göz arasındaki ince kemiklerin etkilenmesine bağlı, **10.000'de 1'den çok daha az** görülen son derece nadir komplikasyonlardır. Gelişirse hastanede, gerekirse yoğun bakımda ek tedavi ve ameliyat gerekebilir; görme kaybı gelişirse kalıcı olabilir.
- **Toksik şok sendromu** — Burun içi tampon kullanımına bağlı, çok nadir ancak acil tedavi gerektiren ciddi bir enfeksiyon tablosudur (ani yüksek ateş, döküntü, tansiyon düşüklüğü). Hastanede, gerekirse yoğun bakımda tedavi gerektirir ve hayatı tehdit edebilir.
- **Psikolojik memnuniyetsizlik** — Teknik olarak başarılı bir sonuca rağmen kişi yeni görünümüne uyum sağlamakta zorlanabilir. Beklentilerin ameliyat öncesi açıkça konuşulması bu riski azaltır.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- Birkaç dakikalık baskıya ve buz uygulamasına rağmen **durmayan veya çok yoğun burun kanaması**
- Ameliyattan sonraki günlerde **artan burun tıkanıklığı, burunda şiddetli ağrı ve şişlik** (septum hematomu/apsesi belirtisi olabilir)
- **38,5 °C üzerinde ateş**, burunda giderek artan ağrı, kızarıklık veya kötü kokulu akıntı
- Tampon varken **ani yüksek ateş, ciltte döküntü, baş dönmesi veya halsizlik**
- Burundan, özellikle öne eğilince artan **berrak, sulu akıntı** veya şiddetli baş ağrısı, ense sertliği
- **Görmede bulanıklık, çift görme** veya göz çevresinde hızla artan şişlik ve ağrı
- Burna darbe alınması veya burnun şeklinde ani değişiklik
- Nefes darlığı veya göğüs ağrısı

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- İlk 2 hafta burnunuzu sümkürmeyiniz; hapşırmanız gerekirse ağzınız açık hapşırınız.
- Burun içi temizliğini size gösterildiği şekilde ve önerilen sıklıkta yapınız.
- En az 6 hafta burnunuza darbe gelmesinden, gözlüğün burun sırtına oturmasından ve yüzüstü yatmaktan kaçınınız.
- Burun cildini en az 3 ay güneşten koruyunuz (yüksek faktörlü güneş kremi, şapka).
- Yurt dışından geldiyseniz uçak yolculuğu genellikle atel çıkarıldıktan sonra (7. gün civarı) güvenlidir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

- ☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.
- ☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa “yoktur” yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Ameliyattan önceki ve sonraki fotoğraflarımın karşılaştırılmasının sonucu değerlendirmenin bir parçası olduğunu; bilgisayar simülasyonu veya örnek fotoğrafların yalnızca fikir vermek amaçlı olup sonuç garantisi olmadığını biliyorum.
- ☐ Bu işlemin **estetik amaçlı** olduğunu, tıbben zorunlu olmadığını ve yaptırmama seçeneğimin her zaman bulunduğunu biliyorum. Beklentilerimi hekimimle konuştum; ulaşılabilecek gerçekçi sonuç bana anlatıldı.
- ☐ Kusursuz simetri veya bir fotoğraftaki görünümün aynısının garanti edilemeyeceğini, nihai sonucun dokularımın iyileşme özelliklerine bağlı olduğunu ve bazı durumlarda düzeltme işlemi gerekebileceğini anladım.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

- ☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.
- ☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.